



Champ : anesthésie programmée (sédation, AG, ALR axiale et/ou périphérique) hors urgence, hors soins critiques, hors anesthésie pédiatrique et obstétricale (fiches dédiées), hors consultation d'évaluation préanesthésique/médecine périopératoire et hors anesthésie locale seule. Objectif : cadre organisationnel des ressources humaines médicales pour sécuriser la prise en charge.

RR

RR = Rappel à la réglementation — la question trouve sa réponse dans un texte légal/réglementaire déjà en vigueur (4 préconisations). **AE = Avis d'experts** — méthode GRADE grid, terminologie RPP « les experts suggèrent » (7 préconisations). Les 11 préconisations ont recueilli un **accord fort dès le premier tour de cotation**, sans distinction de force entre elles — cette distinction RR/AE porte uniquement sur la nature de la source (loi vs avis d'expert), jamais fusionnée avec un niveau de consensus.

Question 1 — Quelle ressource humaine pour assurer la sécurité ?

Réf.	Préconisation	Statut
R1.1	L'acte d'anesthésie est sous la responsabilité exclusive d'un MAR (articles R 4311-12 et R 6153-1-2 CSP).	RR
R1.2	Seuls les IADE sont habilités à accomplir les soins et gestes d'anesthésie-réanimation peropératoire, sous le contrôle exclusif d'un MAR (article R 4311-12 CSP).	RR
R1.3	L'acte d'anesthésie peut être réalisé par un DJ-AR (docteur junior) en autonomie supervisée (article R 6153-1-2 CSP).	RR
R1.4	Un professionnel de l'anesthésie doit être présent pour assurer la surveillance clinique continue du patient anesthésié (articles R 4311-12 et R 6153-1-2 CSP).	RR

Qui fait quoi (repères réglementaires) :

- **MAR** : responsable de la stratégie anesthésique et de sa mise en œuvre ; évalue le patient en amont (acte programmé) ; identifié au dossier d'anesthésie.
- **IADE** : agit sous contrôle exclusif du MAR, à condition qu'un MAR soit présent sur le site et puisse intervenir sans délai (AG, réinjections d'ALR déjà posée par un MAR, surveillance du monitoring, SSPI immédiate).
- **DJ-AR** : autonomie supervisée sur 1 salle ; extension à 2 salles possible en phase de consolidation, après accord conjoint interne/RTS/médecin responsable du site (arrêté du 16/01/2020) ; ne peut pas pratiquer d'anesthésie délocalisée hors bloc opératoire.
- **Ne peuvent pas surveiller un patient sous anesthésie en pleine responsabilité**, même sous supervision d'un MAR : étudiants de 3^e cycle et élèves IADE. Les IBODE, IDE de SSPI et personnels logistiques participent aux soins péri-anesthésiques sans se substituer à la surveillance de l'anesthésie elle-même.

Question 2 — Combien de patients/salles simultanément par MAR ?

Réf.	Préconisation	Statut
R2.1	Le MAR est seul habilité à décider s'il prend la responsabilité d' une ou de deux salles simultanées au maximum .	AE
R2.2	Le MAR est seul habilité à décider de s'adjoindre l'aide d'un IADE par salle, ou d'un IADE pour deux salles.	AE
R2.3	Pour des ALR exclusivement périphériques , le MAR peut prendre en charge plus de deux patients en phase pré-interventionnelle, sous réserve d'une surveillance continue par un IDE formé, sous supervision du MAR (article D6124-94 CSP).	AE
R2.4	Lorsque le MAR a la responsabilité de deux patients simultanément, les deux salles doivent être suffisamment proches l'une de l'autre pour permettre son intervention sans délai.	AE

À noter : la présence d'un IADE en salle n'autorise pas une augmentation du nombre de patients pris en charge par un seul MAR — l'IADE n'est habilité à la surveillance d'une anesthésie « qu'à la condition qu'un MAR puisse intervenir à tout moment » (article R4311-12 CSP). L'usage de salles de pré-induction contiguës n'est conforme que si elles disposent du même environnement matériel et du même personnel qu'une salle d'intervention (décret de 1994) — sinon elles deviennent un site d'anesthésie à part entière, comptant dans le nombre de patients pris en charge simultanément.



Question 3 — Surveillance continue et recours en situation critique

Réf.	Préconisation	Statut
R3.1	Rédiger une procédure organisationnelle au sein de chaque établissement, garantissant une surveillance clinique continue de l'anesthésie par un professionnel de l'AR.	AE
R3.2	Rédiger une procédure de déclenchement d'un renfort pour faire face à une situation critique sur le plateau interventionnel (personne(s) recours identifiée(s), moyens de la/les joindre immédiatement).	AE
R3.3	Pour la création de nouveaux sites d'anesthésie , prévoir une architecture avec un nombre de sites suffisant, à proximité les uns des autres, pour faciliter le recours humain en cas de complication.	AE

- Le recours sera **idéalement un MAR** ; à défaut, dûment justifié, un médecin compétent en soins critiques, voire un IADE selon la situation (ex. aide à une transfusion massive).
- Toute création de site doit éviter une activité anesthésique isolée (bloc à 1-2 salles avec un seul MAR, site hors bloc/plateau technique isolé).

Sources et avertissement

SFAR, à l'initiative du CNP ARMPO, « Préconisations pour les ressources humaines médicales en anesthésie programmée (hors anesthésie pédiatrique et anesthésie obstétricale) », RPP, texte validé par le CA de la SFAR le 02/12/2024. Méthode GRADE grid ; 40 références bibliographiques et textes réglementaires cités dans le texte intégral (non reproduits ici).

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement les 11 préconisations du texte source mais condense l'argumentaire (études de risque, statistiques) et omet la liste nominative des auteurs/relecteurs. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR.